

Protocolo de Reanimação RCR

Corpus didático ampliado com IA. Não é diretriz clínica validada nem orientação de tratamento.

Frase de contexto original

Parada cardiorrespiratória em adultos exige compressões torácicas contínuas de alta qualidade e desfibrilação precoce no código azul.

Reconhecimento e resposta da equipe

Este protocolo didático aborda a resposta à parada cardiorrespiratória em adultos. A reanimação cardiopulmonar, também descrita como ressuscitação cardiopulmonar ou RCP, combina intervenções para sustentar a circulação e a oxigenação. O título RCR foi preservado conforme o documento de origem. No algoritmo para profissionais de saúde, a pessoa é avaliada quanto à resposta, respiração e pulso. Ausência de respiração normal, incluindo respiração agônica, e ausência de pulso definido em até 10 segundos orientam o início da RCP. A equipe aciona a resposta de emergência e providencia o desfibrilador. [1]

Compressões de alta qualidade

As diretrizes de 2025 indicam frequência de 100 a 120 compressões por minuto em adultos. A profundidade deve ser de pelo menos 5 cm, evitando ultrapassar 6 cm, com retorno completo do tórax e interrupções mínimas. A qualidade das compressões é parte essencial da ressuscitação. [2] Na frase original, contínuas deve ser entendido como esforço para reduzir pausas evitáveis, sem eliminar as etapas necessárias do algoritmo. Antes de uma via aérea avançada, profissionais podem realizar ciclos de 30 compressões e duas ventilações. A ventilação deve produzir elevação visível do tórax, evitando excesso. [1, 2]

Organização do código azul

Neste cenário, código azul identifica o acionamento da equipe hospitalar de emergência. A divisão de funções pode contemplar compressões, ventilação, operação do desfibrilador e registro dos eventos. A comunicação deve permitir que cada ação seja anunciada e compreendida pelos profissionais envolvidos.

Protocolo de Reanimação RCR

Corpus didático ampliado com IA. Não é diretriz clínica validada nem orientação de tratamento.

Desfibrilação conforme o ritmo

A desfibrilação precoce se aplica aos ritmos chocáveis, como fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Assistolia e atividade elétrica sem pulso não são tratadas com choque. Por isso, a frase de contexto não deve ser interpretada como indicação de desfibrilar toda parada cardiorrespiratória. [3] No algoritmo de suporte básico, após o choque indicado, a RCP é retomada imediatamente por cerca de dois minutos até a próxima análise. Quando o ritmo não é chocável, as compressões também são retomadas. O desfibrilador externo automático orienta a análise e informa se há indicação de choque. [1]

Exemplo fictício de coordenação

Durante um plantão, a equipe identifica um adulto inconsciente e inicia a avaliação prevista no algoritmo. Um profissional aciona o código azul, outro providencia o desfibrilador e os demais assumem as funções definidas. O responsável pelo registro anota os horários das avaliações e intervenções anunciadas. O relato do evento distingue a chegada do equipamento da aplicação efetiva de um choque. Também informa o ritmo identificado e a sequência das ações. Essa separação evita que a expressão desfibrilador disponível seja confundida com desfibrilação realizada, o que prejudicaria a reconstrução do atendimento.

Registro e revisão do evento

Um formulário de reanimação pode reunir horário de reconhecimento, início das compressões, ritmos analisados, choques administrados e desfecho observado. Cada informação deve corresponder a um evento realmente identificado. Na revisão do caso, a equipe pode avaliar a comunicação e a sequência temporal sem transformar o exemplo em um resultado clínico presumido. Parada cardiorrespiratória, PCR, reanimação, ressuscitação, compressões torácicas, RCP, RCR, desfibrilação e código azul compõem o vocabulário relacionado a este documento.